HORA DOS MISERÁVEIS — CADERNO DE GUERRA

Ciclo 3: Ortopedia Clínica | TEOT 2027

PROPÓSITO

Este Caderno de Guerra é um resumo tático de alta densidade para revisão rápida antes de simulados e da prova do TEOT. Contém flash points, tabelas mentais de classificações, comparações entre conceitos próximos, pegadinhas clássicas e os pontos que mais derrubam candidatos em ortopedia clínica.

1. COLUNA DEGENERATIVA E DEFORMIDADES

1.1 Flash Points — Coluna

Conceito	Flash Point
Hérnia posterolateral L4-L5	Comprime L5 (raiz em trânsito)
Hérnia foraminal L4-L5	Comprime L4 (raiz saindo) — PEGADINHA
Estenose absoluta	Canal < 10mm
Claudicação neurogênica vs vascular	Neurogênica: alivia com flexão (carrinho de supermercado). Vascular: alivia ao parar
Mielopatia cervical — sinais	Hoffmann, Babinski, hiperreflexia, marcha espástica, Lhermitte
ACDF vs posterior	ACDF: 1-2 níveis. Posterior (laminoplastia): ≥ 3 níveis
Cascata de Kirkaldy-Willis	Disfunção → Instabilidade → Reestabilização
Síndrome da cauda equina	EMERGÊNCIA. Retenção urinária + anestesia em sela + déficit motor bilateral. Cirurgia < 48h

1.2 Tabela Mental — Classificações da Coluna

Classificação	O que classifica	Graus/Tipos	Pegadinha
Meyerding	Espondilolistese (deslizamento)	I (< 25%) a V (espondiloptose)	Grau V = vertebrectomia (Gaines)
Wiltse	Etiologia da espondilolistese	I (displásica), II (ístmica), III (degenerativa), IV (traumática), V (patológica)	Tipo II = jovem atleta. Tipo III = idoso SEM lise da pars
Lenke	Escoliose idiopática	Tipos 1-6 + modificador lombar (A,B,C) + sagital (-,N,+)	Tipo 1 = torácica principal (mais comum). Curva não-estrutural corrige > 25° na inclinação
Risser	Maturidade esquelética	0-5 (ossificação da crista ilíaca)	Risser 0-1 = alto risco de progressão
JOA	Mielopatia cervical	0-17 (menor = pior)	Score < 12 = indicação cirúrgica
Bigliani	Morfologia acromial	I (plano), II (curvo), III (ganchoso)	Tipo III = maior risco de impacto/ruptura do manguito

1.3 Comparação — Espondilolistese Ístmica vs Degenerativa

Característica	Ístmica (Wiltse II)	Degenerativa (Wiltse III)
Idade	Jovem (< 30 anos)	Idoso (> 50 anos)
Nível	L5-S1 (mais comum)	L4-L5 (mais comum)
Pars interarticularis	Defeito (lise)	Íntegra
Mecanismo	Fratura de estresse	Degeneração facetária
Raiz comprimida	L5	L4 ou L5
Imagem	Scotty dog decapitado (oblíqua)	Facetas hipertróficas

1.4 Pegadinhas Clássicas — Coluna

1. **Hérnia foraminal vs posterolateral:** A hérnia foraminal em L4-L5 comprime L4 (não L5). A prova adora trocar o nível.
2. **Espondilolistese degenerativa vs ístmica:** A degenerativa NÃO tem lise da pars. Ocorre em L4-L5 (não L5-S1).
3. **Laminoplastia vs laminectomia:** Laminoplastia preserva movimento. Laminectomia isolada (sem fusão) pode causar cifose.
4. **Prótese discal cervical:** Contraindicada na mielopatia, OPLL, instabilidade e artrose facetária.
5. **Doença do segmento adjacente:** Ocorre no nível ACIMA da fusão, não no fusionado.

---

2. OMBRO, COTOVELO, MÃO E PUNHO

2.1 Flash Points — Membro Superior

Conceito	Flash Point
Zona crítica de Codman	Área hipovascular do supraespinhal (1 cm proximal à inserção)
Goutallier ≥ 3	Contraindica reparo isolado do manguito
Perda óssea glenoidal > 20-25%	Indicação de Latarjet (não Bankart)
TUBS vs AMBRI	TUBS = traumática, unidirecional, Bankart, Surgery. AMBRI = atraumática, multidirecional, bilateral, reabilitação
SLAP tipo II	Mais comum e mais cirúrgica (reparo com âncoras)
Arco funcional de Morrey	30-130° flexão, 50° prono/supinação
ECRB	Tendão da epicondilite lateral (tendinose, não tendinite)
STC — atrofia tenar	Indicação cirúrgica obrigatória (liberação do retináculo)
Dupuytren — indicação cirúrgica	MCF > 30° OU IFP qualquer grau
Kienböck IIIA vs IIIB	IIIA = sem colapso carpiano. IIIB = com colapso (capitato migra proximal)

2.2 Tabela Mental — Classificações do MS

Classificação	O que classifica	Graus	Decisão clínica
Neer (impacto)	Síndrome do impacto	I (edema), II (fibrose), III (ruptura)	III = cirurgia
Goutallier	Degeneração gordurosa do manguito	0-4	≥ 3 = irreparável
Patte (retração)	Retração tendínea do manguito	1-3	3 = irreparável
Eaton-Littler	Rizartrose (TMC)	I-IV	III-IV = trapeziectomia + LRTI
Lichtman	Kienböck (NAV semilunar)	I-IV	IIIA = encurtamento rádio; IIIB = artrodese parcial
Green	Dedo em gatilho	I-IV	IV = liberação cirúrgica
McGowan	Neuropatia ulnar no cotovelo	I-III	III = transposição anterior

2.3 Tabela Mental — Testes do Ombro

Teste	Estrutura Avaliada	Como Fazer	Positivo
Jobe (empty can)	Supraespinhal	Abdução 90°, rotação interna, resistência	Dor ou fraqueza
Gerber (lift-off)	Subescapular	Mão nas costas, afasta da coluna	Incapaz de manter
Belly-press	Subescapular	Pressiona abdome, mantém cotovelo anterior	Cotovelo cai para trás
Patte	Infraespinhal	Rotação externa resistida a 90° abdução	Fraqueza
Neer	Impacto subacromial	Elevação passiva com escápula fixa	Dor
Hawkins	Impacto subacromial	Flexão 90° + rotação interna forçada	Dor
O'Brien	SLAP / AC	Flexão 90°, adução 10°, rotação interna, resistência	Dor profunda (SLAP)
Apreensão	Instabilidade anterior	Abdução 90° + rotação externa	Medo de luxar

2.4 Comparação — Deformidades da Mão Reumatoide

Deformidade	Mecanismo	Posição
Pescoço de cisne (swan-neck)	Frouxidão da placa volar da IFP	Hiperextensão IFP + flexão IFD
Botoeira (boutonnière)	Ruptura da banda central do extensor	Flexão IFP + hiperextensão IFD
Polegar em Z	Ruptura do EPL ou sinovite da MCF	Flexão MCF + hiperextensão IF
Desvio ulnar	Subluxação dos extensores para ulnar	Desvio ulnar das MCFs

2.5 Pegadinhas Clássicas — MS

1. **Epicondilite lateral = ECRB (não ECRL).** A patologia é tendinose (não tendinite).
2. **STC — ramo recorrente motor:** Variações anatômicas (Lanz) podem levar à lesão iatrogênica durante liberação.
3. **Kienböck IIIA vs IIIB:** A diferença é o colapso carpiano. IIIA = sem colapso (osteotomia funciona). IIIB = com colapso (precisa artrodese).
4. **Dupuytren — IFP:** Qualquer grau de contratura da IFP já é indicação cirúrgica (pior prognóstico que MCF).
5. **Instabilidade glenoumeral — perda óssea:** > 20-25% da glenoide = Latarjet. Bankart isolado falha.

---

3. QUADRIL

3.1 Flash Points — Quadril

Conceito	Flash Point
Primeiro sinal de artrose do quadril	Limitação da rotação interna
Tönnis 3	Artrose avançada → ATQ
Luxação posterior da ATQ	Flexão > 90° + adução + rotação interna (via posterior)
Tsukayama — infecção periprotética	I = aguda pós-op (< 4 sem), II = hematogênica, III = cultura + intraop, IV = crônica tardia
Vancouver B2	Fratura periprotética + haste solta → revisão da haste
NAV — causa não-traumática mais comum	Corticoide
Ficat II	RX normal + RM positiva → descompressão central
FAI — ângulo alfa > 55°	Deformidade tipo CAM
Cross-over sign	Retroversão acetabular → PINCER
PAO (Ganz)	Displasia + jovem + sem artrose avançada

3.2 Tabela Mental — Classificações do Quadril

Classificação	O que classifica	Graus	Decisão
Tönnis	Artrose do quadril	0-3	≥ 2 = contraindica artroscopia
Ficat	NAV cabeça femoral	I-IV	I-II = descompressão; III-IV = ATQ
ARCO	NAV cabeça femoral	I-IV (similar Ficat, mais detalhado)	Colapso = ARCO III
Crowe	Displasia (DDQ adulto)	I-IV	III-IV = ATQ complexa
Paprosky (acetábulo)	Defeito ósseo acetabular (revisão ATQ)	I, IIA-C, IIIA-B	IIIB = reconstrução com cage/anel
Paprosky (fêmur)	Defeito ósseo femoral (revisão ATQ)	I-IV	IV = prótese composta ou megaprótese
Vancouver	Fratura periprotética fêmur	A, B1-B3, C	B2 = haste solta → revisão
Tsukayama	Infecção periprotética	I-IV	IV crônica = 2 tempos

3.3 Comparação — Abordagens da ATQ

Abordagem	Intervalo	Risco Nervoso	Risco de Luxação	Vantagem
Posterior (Moore)	Rotadores externos	Ciático	Posterior (mais comum)	Visualização femoral
Anterolateral (Hardinge)	Glúteo médio (split)	Glúteo superior	Anterior	Menor taxa de luxação
Anterior direta (Hueter)	Sartório-TFL / reto femoral	Cutâneo femoral lateral	Muito baixa	Recuperação rápida

3.4 Pegadinhas Clássicas — Quadril

1. **Luxação ATQ posterior vs anterior:** Posterior = flexão + adução + RI (via posterior). Anterior = extensão + RE (via anterior). A prova troca as vias.
2. **Vancouver B1 vs B2:** B1 = haste FIXA (fixação da fratura). B2 = haste SOLTA (revisão da haste). A diferença é a estabilidade da haste.
3. **NAV — Ficat I vs II:** Ficat I = RX e RM normais (só cintilografia +). Ficat II = RX normal, RM positiva. A prova confunde os dois.
4. **FAI — artroscopia contraindicada:** Tönnis ≥ 2 ou espaço articular < 2mm = artrose avançada = NÃO fazer artroscopia.
5. **Osteotomia periacetabular:** Só para displasia SEM artrose avançada, < 40 anos, congruência preservada.

---

4. JOELHO

4.1 Flash Points — Joelho

Conceito	Flash Point
Lachman	Teste MAIS SENSÍVEL para LCA
Pivot-shift	Teste MAIS ESPECÍFICO para LCA
Dashboard injury	Mecanismo clássico do LCP
LCP grau III	> 10mm translação posterior → cirurgia
Menisco lateral agudo	Lesão associada mais comum na ruptura aguda do LCA
Menisco medial crônico	Lesão associada mais comum na insuficiência crônica do LCA
Zona vermelha-vermelha	Reparo meniscal (vascularizada)
Zona branca-branca	Meniscectomia parcial (avascular)
Kellgren-Lawrence 3-4	Artrose moderada-grave → considerar ATJ
HTO — ponto de Fujisawa	Eixo mecânico para 62% da largura do platô tibial
Outerbridge IV	Osso subcondral exposto
MPFL	Estabilizador primário da patela (reconstrução na instabilidade recorrente)

4.2 Tabela Mental — Classificações do Joelho

Classificação	O que classifica	Graus	Decisão
Kellgren-Lawrence	Artrose do joelho	0-4	3-4 = considerar ATJ
Outerbridge	Condropatia (artroscópica)	I-IV	IV = osso exposto
Watanabe	Menisco discoide	Completo, incompleto, Wrisberg	Saucerização (não meniscectomia total)
Insall-Salvati	Altura patelar	> 1,2 = patela alta	Patela alta = fator de instabilidade
Dejour	Displasia troclear	A-D	D = mais grave (proeminência + cliff)
Schenck	Luxação do joelho	I-V	Todas = avaliar lesão vascular (poplítea)
AORI	Defeito ósseo (revisão ATJ)	I-III	III = megaprótese ou aloenxerto

4.3 Comparação — HTO vs UKA vs ATJ

Critério	HTO	UKA	ATJ
Idade ideal	< 60 anos	55-75 anos	> 55-60 anos
Compartimento	Medial unicompartimental	Medial unicompartimental	Tricompartimental
LCA	Pode estar deficiente	DEVE estar íntegro	Irrelevante
Deformidade	Varo < 15°	Varo < 10°	Qualquer
IMC	< 30	< 30-35	Qualquer
Arco de movimento	> 90°	> 90°	Qualquer
Atividade	Alta (esporte)	Moderada	Baixa-moderada

4.4 Pegadinhas Clássicas — Joelho

1. **Lachman vs gaveta anterior:** Lachman é MAIS SENSÍVEL (menos influenciado pelo espasmo muscular). Gaveta anterior pode ser falso-negativo na fase aguda.
2. **Menisco lateral vs medial na lesão do LCA:** AGUDA = lateral. CRÔNICA = medial. A prova inverte.
3. **UKA — LCA deve estar íntegro.** Se LCA rompido, UKA é contraindicada (diferente da HTO).
4. **Instabilidade patelar — primeiro episódio:** Tratamento CONSERVADOR (não cirúrgico). Cirurgia só na recorrência.
5. **OCD — esqueleto imaturos:** Tratamento conservador se lesão estável. Cirurgia se instável ou esqueleto maduro.

---

5. TORNOZELO E PÉ

5.1 Flash Points — Tornozelo e Pé

Conceito	Flash Point
Tendão tibial posterior	Causa primária do pé plano adquirido do adulto
Single heel rise test negativo	Disfunção do TTP (estágio II+)
Too many toes sign	Abdução do antepé (pé plano)
Teste de Coleman positivo	Varo FLEXÍVEL, originado no antepé (CMT)
Teste de Coleman negativo	Varo RÍGIDO, originado no retropé
Broström-Gould	Padrão-ouro para instabilidade crônica lateral do tornozelo
Fleck sign	Patognomônico de lesão de Lisfranc
Thompson positivo	Ruptura do tendão de Aquiles (sem flexão plantar ao comprimir panturrilha)
Fascite plantar — primeiro passo	Dor nos primeiros passos da manhã, melhora com atividade
Neuroma de Morton	3º espaço intermetatarsal (mais comum)

5.2 Tabela Mental — Classificações do Tornozelo e Pé

Classificação	O que classifica	Graus	Decisão
Johnson-Strom/Myerson	Pé plano adquirido (TTP)	I-IV	I = sinovectomia; II = FDL + osteotomia calcâneo; III = artrodese tríplice; IV = pantalar
Sanders	Fratura do calcâneo (TC)	I-IV	I = conservador; II-III = RAFI; IV = artrodese primária
Hawkins	Fratura do tálus (NAV)	I-IV	Hawkins sign (+) = BOM prognóstico (revascularização)
Coughlin	Hallux rigidus	0-4	0-2 = queilectomia; 3-4 = artrodese 1ª MTF
Watanabe	Menisco discoide	Completo, incompleto, Wrisberg	Saucerização

5.3 Comparação — Hallux Valgus: Escolha da Osteotomia

Gravidade	Ângulo HV	IMA	Osteotomia
Leve	< 20°	< 11°	Chevron distal
Moderado	20-40°	11-16°	Scarf ou proximal + McBride
Grave	> 40°	> 16°	Proximal + McBride ou Lapidus
Com hipermobilidade	Qualquer	Elevado	Lapidus (artrodese TMT)

5.4 Comparação — Pé Plano: Estágios e Tratamento

Estágio	Deformidade	TTP	Tratamento
I	Sem deformidade	Tenossinovite	Órtese + fisioterapia ou sinovectomia
IIA	Flexível, < 40% descoberta talar	Disfunção	FDL + osteotomia medialização calcâneo
IIB	Flexível, > 40% descoberta	Disfunção	FDL + osteotomia + alongamento coluna lateral (Evans)
III	Rígida	Ruptura	Artrodese tríplice
IV	Rígida + valgo tibiotalar	Ruptura	Artrodese tríplice + deltoidea ou pantalar

5.5 Pegadinhas Clássicas — Tornozelo e Pé

1. **Hawkins sign:** Sinal POSITIVO = BOM prognóstico (osteopenia subcondral = revascularização). A prova tenta fazer o aluno pensar que é sinal de necrose.
2. **Sanders tipo IV:** Fratura cominutiva do calcâneo → artrodese subtalar primária (não RAFI).
3. **Pé plano estágio II vs III:** II = flexível (osteotomia). III = rígido (artrodese). A diferença é a flexibilidade.
4. **Teste de Coleman:** Positivo = varo flexível do ANTEPÉ. Negativo = varo rígido do RETROPÉ. A prova inverte.
5. **Lisfranc — RX em carga:** A diastase pode NÃO aparecer em RX sem carga. Sempre pedir RX em carga bilateral comparativo.

---

6. PONTOS QUE MAIS DERRUBAM CANDIDATOS

6.1 Top 10 — Erros Mais Frequentes em Ortopedia Clínica

Rank	Erro	Tema	Por que erra
1	Confundir hérnia foraminal com posterolateral	Coluna	Não domina a relação raiz-nível por localização
2	Indicar Bankart para perda óssea > 25%	Ombro	Não sabe o limiar para Latarjet
3	Confundir Ficat I com II	Quadril NAV	Não sabe que Ficat I = RX E RM normais
4	Indicar artroscopia na artrose avançada	Quadril/Joelho	Não sabe as contraindicações
5	Confundir Vancouver B1 com B2	ATQ	Não avalia estabilidade da haste
6	Tratar instabilidade patelar primária com cirurgia	Joelho	Não sabe que 1º episódio = conservador
7	Achar que Hawkins sign = necrose	Tálus	Inverte o significado (positivo = BOM)
8	Confundir pé plano estágio II com III	Pé	Não diferencia flexível de rígido
9	Indicar UKA com LCA rompido	Joelho	Não sabe que LCA íntegro é pré-requisito
10	Não reconhecer Dupuytren com diátese	Mão	Não sabe os critérios de doença agressiva

6.2 Regras de Ouro para a Prova

1. **Na dúvida entre conservador e cirúrgico:** Se o paciente é jovem e ativo com patologia mecânica, a tendência é cirúrgica. Se é idoso com patologia degenerativa leve, conservador primeiro.

2. **Classificações são a moeda do TEOT.** Decore Lenke, Meyerding, Tönnis, Ficat, Kellgren-Lawrence, Eaton-Littler, Lichtman, Johnson-Strom, Sanders, Hawkins. Cada uma define conduta.

3. **Complicações pós-operatórias:** A prova adora perguntar a complicação MAIS COMUM de cada procedimento. Saiba: ATQ (luxação posterior via posterior), ATJ (infecção é a causa mais comum de revisão precoce), LCA (artrofibrose), artrodese lombar (segmento adjacente).

4. **Exame físico é rei.** Saiba TODOS os testes especiais do ombro, joelho, mão e pé. A prova cobra o teste, a estrutura avaliada e a interpretação.

5. **Imagem define conduta.** RX em carga (joelho, pé), RM com artro-RM (labrum, SLAP), TC (calcâneo, pars), ENMG (STC). Saiba quando pedir cada um.

---

7. FLASHCARDS ESSENCIAIS — REVISÃO RELÂMPAGO

Pergunta	Resposta
Hérnia posterolateral L4-L5 comprime qual raiz?	L5
Hérnia foraminal L4-L5 comprime qual raiz?	L4
Quantas vértebras com cunha ≥ 5° definem Scheuermann?	≥ 3 adjacentes
Indicação de colete na escoliose?	25-45°, esqueleto imaturos (Risser 0-2)
Indicação cirúrgica na escoliose?	> 45-50°
Tendão da epicondilite lateral?	ECRB
Indicação cirúrgica no Dupuytren?	MCF > 30° OU IFP qualquer grau
Kienböck IIIA vs IIIB?	IIIA = sem colapso. IIIB = com colapso
Perda óssea glenoidal para Latarjet?	> 20-25%
Arco funcional de Morrey?	30-130° flexão, 50° prono/supinação
Primeiro sinal de artrose do quadril?	Limitação da rotação interna
Causa não-traumática mais comum de NAV?	Corticoide
Ficat II = ?	RX normal + RM positiva
Teste mais sensível para LCA?	Lachman
Teste mais específico para LCA?	Pivot-shift
LCP grau III = ?	> 10mm translação posterior
Ponto de Fujisawa na HTO?	62% da largura do platô tibial
Insall-Salvati > 1,2 = ?	Patela alta
Causa do pé plano adquirido do adulto?	Disfunção do tendão tibial posterior
Hawkins sign positivo = ?	BOM prognóstico (revascularização)

Pergunta	Resposta
Sanders IV = ?	Artrodese subtalar primária
Fleck sign = ?	Lesão de Lisfranc
Teste de Thompson positivo = ?	Ruptura do tendão de Aquiles
Neuroma de Morton — espaço mais comum?	3º intermetatarsal
Broström-Gould = ?	Reparo anatômico da instabilidade lateral do tornozelo

---